

과민성장증후군(IBS) 식사 가이드 — 저FODMAP 3단계

과민성장증후군은 장과 뇌의 신호가 예민해져 생기는 **장-뇌 상호작용 질환**입니다. 마음의 문제가 아니며, 식단 조절만으로도 10명 중 5~8명에서 복통·팽만 증상이 뚜렷이 좋아집니다.

한눈에 보는 핵심 수치

증상 호전률

50~86

% (저FODMAP 식단)

1단계 제한기

2~6

주 (평생 아님!)

2단계 재도입

6~8

주 (그룹별 시험)

3단계 개인화

평생

나만의 식단 유지

● 마늘·양파·밀가루 식사 후
— 복통·팽만

● 저FODMAP 식사 후 —
편안한 일상

같은 사람이라도 무엇을 먹었는지에 따라 증상이 달라집니다 — 음식은 IBS의 가장 강력한 조절 스위치입니다.

FODMAP이 증상을 일으키는 원리

FODMAP = 장에서 흡수되지 않는 발효성 당류

- ① 소장에서 흡수되지 못하고 — 물을 장 안으로 끌어들이며 설사·꾸르륵 소리를 유발합니다.
- ② 대장에서 세균에 의해 발효되어 — 가스가 차고 장이 부풀어 팽만감이 생깁니다.
- ③ 예민해진 장은 이 자극을 통증으로 — 같은 가스량에도 IBS 환자는 더 아프게 느낍니다.

대표 FODMAP: 과당(사과·꿀) · 유당(우유) · 프락탄(마늘·양파·밀) · GOS(콩류) · 폴리올(자일리톨·수박)

● 소장 — 물 유입

● 대장 — 가스 발효

저FODMAP 식단 3단계 — 반드시 끝까지 진행하세요

1단계 · 제한

2~6주 만!

고FODMAP 식품을 모두 줄이고 증상 일지를 씁니다. 좋아지는지 확인하는 진단 단계이며, **장기간 지속하면 장내 유익균과 영양이 손해를 봅니다.**

2단계 · 재도입

6~8주

FODMAP 그룹을 **한 번에 하나씩, 3일 간격**으로 다시 먹어보며 나의 '진짜 범인'과 견딜 수 있는 양을 찾습니다.

3단계 · 개인화

평생 유연하게

문제 없는 음식은 모두 되돌리고, 문제 식품만 양을 조절합니다. **가장 다양하게 먹으면서 증상 없는 식단이 최종 목표**입니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ACG 2021 · AGA 2022 · Rome IV · Monash University FODMAP Database

본 자료는 일반적 권고이며, 증상·동반질환에 따라 식이 처방이 달라질 수 있습니다. 제한기는 가능한 범위 의료진·영양사와 함께 진행하세요. 다음 장에 한국 음식 FODMAP 신호등과 실천 수칙이 이어집니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/lifestyle/ibs-fodmap-diet/

한국 음식 FODMAP 신호등과 실천 수칙

김치·된장까지 끓을 필요는 없습니다. 한식 기준으로 '마음껏 · 양 조절 · 잠시 중단'을 나누고, 흔한 오해와 일상 실천법을 정리했습니다.



한국 음식 FODMAP 신호등 (제한기 2~6주 기준)

분류	대표 식품	한식 팁	판정
마음껏	쌀밥·감자 · 고기·생선·달걀 · 단단한 두부 · 오이·당근·상추· 애호박 · 바나나·딸기·키위	배추는 한 끼 75g까지 안전 — 배추전·겉절이 소량 OK	안심
양 조절	김치 2~3큰술 · 전통 된장 1큰술(12g) · 간장 · 고구마 ½개	김치는 1~2젓가락부터 늘리며 증상 기록 — 끊지 않아도 됩니다	소량 OK
잠시 중단	마늘·양파 (소량도) · 밀가루(빵·면·라면) · 사과·배·수박 · 우유· 아이스크림 · 콩류·버섯 · 꿀·올리고당	고추장·쌈장·시판 양념은 마늘·물엿 때문에 제한기엔 보류	제한기 회피

※ 같은 식품도 양에 따라 판정이 달라집니다 — '무엇을'보다 '얼마나'가 핵심 (Monash 측정 기준). 대체하기: 마늘 → 마늘향 기름·파 초록 부분 · 밀면 → 쌀국수·100% 메밀 · 우유 → 락토프리 · 꿀 → 설탕 소량.

흔한 오해 3가지 & 매일 실천 수칙 7가지

오해 바로잡기 (MYTH → FACT)

"평생 엄격하게 가려 먹어야 한다"

→ 엄격한 제한은 2~6주만. 그 후엔 다시 늘려가는 것이 정석입니다.

"글루텐(밀)을 무조건 끊어야 한다"

→ 진짜 원인은 글루텐이 아닌 밀의 **프락탄**인 경우가 많습니다. 설사형은 셀리악병 검사를 먼저 확인합니다.

"스트레스 때문이니 마음먹기 나름이다"

→ IBS는 장 운동·감각 이상이 확인되는 **실체 신체 질환**입니다. 스트레스는 악화 요인일 뿐 원인의 전부가 아닙니다.

매일 실천 수칙 7

1. 규칙적으로, 소량씩, 천천히 먹고 과식을 피합니다.
2. 증상 일지 — 먹은 것과 증상을 2주간 기록해 나만의 유발 음식을 찾습니다.
3. 마늘·양파부터 점검 — 가장 흔한 '숨은 범인'입니다.
4. 성분표 확인 — 양념·가공식품의 마늘·양파·밀·올리고당.
5. 카페인·알코올·탄산·고지방·강한 매운맛을 줄입니다.
6. 변비형은 수용성 섬유(차전자피·귀리)를 소량부터 천천히 + 물 충분히.
7. 좋아져도 재도입 단계를 꼭 진행 — 평생 제한이 목표가 아닙니다.

▲ 식단 조절보다 진료가 먼저인 위험 신호

다음 중 하나라도 있으면 식단 실험을 멈추고 바로 진료·검사를 받으세요 — 혈변·흑색변 · 의도하지 않은 체중 감소 · 빈혈 · 자다가 깬 정도의 야간 복통/설사 · 50세 이후 새로 시작된 증상 · 대장암/염증성 장질환 가족력 · 발열. ☎ 031-893-4560